

手術をすすめられながら、手術がいやでのばして

ファンピシン、エタンブロールを併用してなおせる。
ストレプトマイシンとピラジナマイドは禁物である。

てんかんが両親のどちらかにあっても、それだけでは避妊の理由にならない。そういう夫婦にできる子がてんかんになる可能性は30組に1人ぐらいだ。妊娠したためにてんかんがわるくなるのは、14ほどだ。

抗けいれん剤が奇形をおこす可能性は薬によってちがう。統計の数字がいろいろなのは、原因がてんかんの遺伝因子によるか、薬のためかわからないからである。妊娠中は血液の中の薬の量がひくくなるから、月に1度は血液のモニターをする。へつていたらのむ薬の量をふやす。妊娠したからといって薬をやめることはない。妊娠がてんかんの発作をおこしやすくなると思われたのは、薬の量をへらしたためらしい。出産後は薬の量をもとにもどす。バルプロ酸以外は多少とも母乳に移行するが、赤ちゃんに異常(ねむくなる)がでれば薬を加減すればよい。

バセドウ病(甲状腺機能亢進症)とわかっていてる母親も治療薬をつづけながら無事出産できるようなになった。甲状腺のはたらきを正確にとらえる検査が進歩して薬の分量をうまく加減できるからである。甲状腺を上げきする物質(抗体)が胎盤を通して胎児にとどいても、妊娠中期までは胎児の甲状腺は反応し

ない。中絶後は場合によって胎児の甲状腺機能が高まるが、母親がのんでいる薬が適量なら、それがきく。出産後数日で赤ちゃんが甲状腺機能亢進をおこすこともあるが、薬でなおる。産後母親がのむ薬が母乳にでてくるが、普通量では乳児に害はない。

フェニールケトン尿症で乳児期から治療食を10年以上つづけてなおり、普通食にもどっていた女性が妊娠すると、胎児の脳や心臓に異常をおこすことがわかってきた。妊娠とわかってからフェニールアラニンの少ない治療食にかえたのではまにあわない。結婚したら治療食にもどす。出産後は母乳を与えない。フェニールケトンが多量にふくまれているからである(639フェニールケトン尿症)。

高血圧と産科でいうのは、収縮期血圧(俗に最高血圧)が140以上、拡張期血圧(最低血圧)90以上である。内科で高血圧といわれていない人もはいる。

妊娠前に血圧の高くなかった人が、妊娠したために高血圧になることがある。妊娠24週ごろがおおい。妊娠による高血圧の人は、尿にタンパクがなく、むくみもなかったら、自宅でやれる。血圧が相当に高くて血圧を下げる薬で正常になる人もおなじだ。治療は安静が第一である。たいてい産科医から、食事のカロリーのさげ、塩分を少なくするようにいわれるだろう。安静にし、食事をかえただけで血圧がさがれば、降圧剤はのまないでいい。

血圧をさげる薬をのんでも血圧が高かったり、尿にタンパクがでてきたりすれば入院する。胎盤剥離、早産や胎児の成長のおくれるのを予防するためだ。